

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת ארז מלול

פ/3695/25

הצעת חוק טיפול בחולי נפש (תיקון – תנאי אשפוז הולמים), התשפ"ג–2023

הוספת סעיף 35א¹. בחוק טיפול בחולי נפש, התשנ"א–1991¹, אחרי סעיף 35 יבוא :

"תנאי אשפוז 35א. (א) חולה, המאושפז בבית חולים (בסעיף זה – הולמים" מאושפז) יטופל בתנאים הולמים שלא יהיה בהם כדי לפגוע בבריאותו ובכבודו.

(ב) מאושפז יהיה זכאי, בין השאר, לכל אלה :

(1) תנאי תברואה הולמים, תנאים שיאפשרו לו לשמור על ניקיונו האישי, טיפול רפואי הנדרש לשם שמירה על בריאותו, ותנאי השגחה מתאימים לפי דרישת רופא ;

(2) מיטה, מזון ושמירות לשימוש האישי, ומקום להחזקת חפצים אישיים שלו ;

(3) מי שתייה וכן מזון בכמות ובהרכב המתאימים לשמירה על בריאותו ;

(4) בגדים, מוצרים לשמירה על ניקיון אישי ומצעים ;

(5) הליכה יומית באוויר הפתוח.

(ג) לעניין מקום הלינה של המאושפז ומקום השהות היומי שלו יחולו כל אלה :

(1) מקום הלינה ומקום השהות היומי, יהיו בתנאי תאורה ואוורור ראויים ;

¹ ס"ח התשנ"א, עמ' 58.

(2) מקום הלינה ומקום השהות היומי
יאפשרו מרחב מחיה אישי הולם.

(ד) (1) ראש שירותי בריאות הנפש ימסור
לשר, ב-31 בינואר בכל שנה, דיווח על יישום
הוראות סעיף זה בבתי החולים בשנה
שקדמה לה;

(2) השר ימסור עד 1 באפריל בכל שנה
דיווח לוועדת הבריאות של הכנסת על
יישום הוראות סעיף זה."

דברי הסבר

מתמודדי נפש סובלים זה שנים רבות מסטיגמה, מאפליה ומהזנחה. הביטוי העיקרי לכך הוא תנאי
הצפיפות הבלתי נסבלים בחדרי האשפוז בבתי החולים הפסיכיאטריים. סעיף 35 לחוק טיפול בחולי נפש
התשנ"א–1991, מגדיר את זכויות החולה המאושפז במסגרות, אך אין בו כל התייחסות לתנאי האשפוז
ההולמים שיש להבטיח עבור המטופלים.

האוכלוסייה המגיעה למחלקות הפסיכיאטריות אינה בעלת חוסן נפשי, ומושפעת מאופן קבלת
הטיפול ואיכותו. כך, לשטח המחיה יש השפעה ישירה ועקיפה על תהליך החלמת המאושפזים במערך
הפסיכיאטרי. בעיית מרחב המחיה של המאושפזים ידועה למשרד הבריאות כבר שנים ארוכות, אך לא
נבנתה כל תכנית ממשלתית על מנת להתמודד עם המשבר.

צפיפות היא המשתנה הסביבתי המשמעותי ביותר, והיא הוכחה כמשפיעה על התנהגות אלימה
במחלקות פסיכיאטריות, בכך שהיא חושפת את החולה הפסיכיאטרי למצבי דחק, עומס, גירויים והיעדר
פרטיות. מחובתה של המדינה להבטיח שטח מחיה ותנאי אשפוז הולמים עבור המאושפזים, וכן לפעול כל
העת לשיפור וטיוב איכות הטיפול.

בעוד שביחס לבתי הסוהר קיים סטנדרט סטטוטורי לתנאי המחיה של אסירים, ביחס לבתי החולים
לבריאות הנפש לא נקבע הסדר סטטוטורי דומה. סעיף 11 לפקודת בתי הסוהר [נוסח חדש], התשל"ב–
1971, קובע כי אסיר יוחזק בתנאי כליאה הולמים "שלא יהיה בהם כדי לפגוע בבריאותו ובכבודו". עוד
כתוב כי "השר רשאי לקבוע בתקנות הוראות לביצוע סעיף זה". על סמך החוק, תקנה 2(ח) לתקנות בתי
הסוהר (תנאי מאסר), התש"ע–2010 קובעת כי השטח הממוצע לאסיר בתא לא יפתח מארבעה וחצי
מטרים רבועים לפי חישוב השטח בין קירות התא, לרבות שטח השירותים, הכיור והמקלחת; וכן, תקנה
2(ז) הקובעת כי בכל תא לא יהיו יותר מארבע מיטות לאסירים.

לעומת זאת, במערכת הפסיכיאטרית, אין התייחסות לשטחי המחיה או לסטנדרט התשתיות של בתי
החולים. בהעדר חקיקה קונקרטית בעניין, לא נקבעו תקנות ומצבן של המחלקות הפסיכיאטריות בכי רע.
יש צורך בקביעת סטנדרט מספרי של שטח מחיה מינימאלי לכל מאושפז. האשפוז איננו מסגרת ענישה,
בין אם נעשה בכפייה ובין אם לאו. המדינה חייבת לקבוע תנאים ולפקח עליהם, מחובתה להגן על
המאושפזים. אם לגבי אסירים ועוברי עבירה דואגת המדינה לתנאים הולמים, על אחת כמה וכמה
שמאושפזים אשר נקלעו למצבם בלא עוול בכפם, ראויים לתנאים אלו.

מטרתה של הצעת חוק זו להבטיח תנאי אשפוז הולמים במערכת הפסיכיאטרית. מוצע כי בכל בית חולים יובטחו לחולה תנאי תברואה הולמים, מי שתיה ומזון, בגדים, תנאי תאורה ואוורור והליכה יומית באוויר הפתוח.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת מיכל מרים וולדיגר וקבוצת חברי הכנסת (פ/3139/24), על ידי חברת הכנסת עידית סילמן (פ/3885/24) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברת הכנסת מיכל מרים וולדיגר (פ/67/25), על ידי חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין וקבוצת חברי הכנסת (פ/1417/25) ועל ידי חבר הכנסת אוהד טל וקבוצת חברי הכנסת (פ/1830/25).

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת עידית סילמן (פ/3997/24) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברת הכנסת עידית סילמן (פ/676/25) ועל ידי חבר הכנסת ואליד אלהואשלה (פ/1833/25).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"א בתמוז התשפ"ג (10.07.2023)